

# Prolapso de los órganos pélvicos

Guía de cuidados y ejercicios · Información para la paciente

*Recupera el control y la confianza: muchos síntomas mejoran con medidas sencillas y ejercicios del suelo pélvico realizados con constancia.*

## ¿Qué es?

El prolapso es el **descenso de uno o varios órganos pélvicos** (vejiga, útero o recto) por un debilitamiento del suelo pélvico, que actúa como hamaca de sostén. Puedes notar **sensación de bulto o peso** en la vagina, presión o que "algo baja", sobre todo al final del día o con el esfuerzo.

**Buena noticia:** en los prolapsos leves y moderados, el tratamiento conservador (ejercicios, hábitos y, si procede, pesario) es la primera opción y mejora los síntomas en gran parte de las mujeres.

## Ejercicios del suelo pélvico (Kegel)

Una vez localizada la musculatura, empieza **tumbada boca arriba, con las rodillas flexionadas** y los pies apoyados. Más adelante podrás hacerlos sentada o de pie. La contracción es **hacia dentro y en sentido ascendente**, como para **aguantar la orina y un gas a la vez**.

### Ejercicio 1 · lento

Contrae 5 s soltando el aire por la boca y **descansa 10 s**. El descanso es tan importante como la contracción.  
**10 repeticiones**

### Ejercicio 2 · rápido

Contrae 1 s y descansa 1 s, con un ritmo claro de "activar y soltar".  
**10 repeticiones**

### Frecuencia y progresión

Ambos ejercicios 2-3 veces/día. Con soltura, alarga la contracción del lento y sube las repeticiones del rápido.  
**2-3 veces/día**

### Claves para hacerlos bien

- **Suelta el aire al contraer** y nunca contengas la respiración.
- **Respetar el descanso** tras cada contracción: si no, puedes sobrecargar la musculatura y empeorar los síntomas.
- **No aprietes** la barriga, las piernas ni los glúteos.
- Cuando los domines, intégralos en el día a día: en el transporte, en una cola o viendo el móvil o la tele.

**Truco protector ("the knack"):** contrae el suelo pélvico **justo antes** de toser, estornudar, reír o levantar peso. Da soporte extra y reduce los escapes.

## El pesario, una opción de apoyo

El pesario es un **dispositivo de silicona** que se coloca en la vagina para sostener los órganos. Es una alternativa eficaz cuando no se desea o no se puede operar, o mientras se trabaja la musculatura. Tu ginecólogo valorará si te conviene y qué tipo y talla son adecuados.

## Medidas generales: hábitos que cuidan tu suelo pélvico

- **Controla tu peso:** dieta rica en fruta, verdura, cereales y legumbres. El sobrepeso añade presión sobre el suelo pélvico.
- **Reduce los irritantes de la vejiga:** café, té, alcohol, chocolate, comidas picantes o grasas.
- **Bebe con moderación:** entre 1,5 y 2 litros al día, repartidos; reduce la ingesta 3-4 horas antes de acostarte.
- **Combate el estreñimiento** con dieta equilibrada y abundante fibra.
- **No fumes:** el humo irrita la vejiga y la tos crónica debilita el suelo pélvico.
- **Ejercicio de bajo impacto** (natación, elíptica, bici de paseo, hipopresivos, o un paseo diario de media hora); evita los deportes de impacto (correr, crossfit, spinning). El Pilates, solo dirigido por un experto.
- **Postura correcta al defecar:** rodillas por encima del nivel de las caderas, codos sobre las rodillas, y exhala lentamente por la boca sin apretar en apnea.
- **Higiene íntima:** lávate solo con agua separando bien los labios, y de delante hacia atrás para evitar infecciones.
- **Evita la ropa que oprima el abdomen** y no abusos del tacón.
- **Revisa tu medicación** con tu médico (antihipertensivos, diuréticos, tranquilizantes) por si conviene ajustar dosis u horarios.



### **Cuándo consultar**

- ! El bulto aumenta, sangra, se ulcera o causa dolor.
- ! Dificultad para orinar o defecar, o para vaciar por completo.
- ! Escapes de orina o de heces que no mejoran.
- ! Molestias en las relaciones sexuales.

Recupera el control y la confianza: el primer paso lo das tú.

*Elaborado a partir de guías de práctica clínica (NICE NG123, ICS, EAU) y material de la Unidad de Suelo Pélvico. Ejercicios estándar de fisioterapia del suelo pélvico. Pendiente de revisión clínica.*